

USO INDISCRIMINADO DE ANTIBIÓTICOS Y EL ROL DEL FARMACÉUTICO: ANÁLISIS CRÍTICO DURANTE PASANTÍAS PROFESIONALES.

Autores: Antonio Touma, Stephany Salazar.

Universidad Santa María, Facultad de Farmacia, Caracas, Venezuela

RESUMEN

El uso indiscriminado e inapropiado de agentes antimicrobianos se ha consolidado como una de las crisis sanitarias más urgentes del siglo XXI, comprometiendo severamente la eficacia de la medicina contemporánea y agravándose por la persistente práctica de la automedicación en cuadros virales donde estos fármacos carecen de actividad farmacológica. La adquisición de antibióticos prescindiendo de un recípe médico formal vulnera los protocolos de seguridad y la vigilancia sanitaria, dado que este documento es el único que garantiza una indicación y posología analizadas bajo criterios científicos específicos. A largo plazo, esta exposición innecesaria induce una presión selectiva que origina superbacterias y altera profundamente la microbiota intestinal, desencadenando disfunciones inmunológicas y metabólicas. En la práctica diaria, se evidencia una brecha preocupante entre la normativa legal vigente y la demanda espontánea de fármacos como la azitromicina, situación que genera actitudes desfavorables en los pacientes al interpretar el control sanitario como un obstáculo administrativo. Por consiguiente, aunque el farmacéutico es el garante fundamental del uso racional del medicamento, su labor se ve comprometida por la presión comercial y la limitada educación sanitaria

de la población. Finalmente, se determina que es imperativo fortalecer la fiscalización institucional y la comunicación asertiva para preservar el arsenal terapéutico, entendiendo que el cumplimiento riguroso de la prescripción médica es la única vía para mitigar la amenaza de la resistencia antimicrobiana global y garantizar la seguridad del paciente.

Palabras clave: Antibióticos, Automedicación, Resistencia Antimicrobiana y Recípe Médico.

ABSTRACT

The indiscriminate and inappropriate use of antimicrobial agents has emerged as one of the most urgent health crises of the 21st century, severely compromising the efficacy of contemporary medicine and being further exacerbated by the persistent practice of self-medication in viral cases where these drugs lack pharmacological activity. Acquiring antibiotics without a formal medical prescription violates safety protocols and sanitary surveillance, given that this document is the only guarantee of an indication and dosage analyzed under specific scientific criteria. In the long term, this unnecessary exposure induces selective pressure that originates superbugs and profoundly alters the intestinal microbiota, triggering immunological and metabolic dysfunctions. In daily practice, a concerning gap is evident between current legal regulations and the spontaneous demand for drugs such as azithromycin, a situation that generates unfavorable attitudes in patients who interpret sanitary control as an administrative obstacle. Consequently, although the pharmacist is the fundamental guarantor of the rational use of medicine, their role is compromised by commercial pressure and the population's limited health education. Ultimately, it is determined that it is imperative to strengthen

institutional oversight and assertive communication to preserve the therapeutic arsenal, understanding that rigorous compliance with medical prescriptions is the only way to mitigate the threat of global antimicrobial resistance and guarantee patient safety.

Keywords: Antimicrobial Resistance, Antibiotics, Medical Prescription and Self-medication.

INTRODUCCIÓN

I. Justificación

La automedicación de antibióticos es un problema de salud pública de dimensiones globales, el cual ha alcanzado niveles críticos en el entorno de las farmacias comerciales. En estos establecimientos, se observa con frecuencia una conducta recurrente por parte de los usuarios, quienes acuden solicitando agentes antimicrobianos de amplio espectro para tratar sintomatologías que, en su mayoría, corresponden a infecciones virales autolimitadas. Esta práctica no solo contraviene los protocolos terapéuticos establecidos, sino que refleja un gran desconocimiento en la educación sanitaria del paciente, quien ignora que el uso injustificado de estos fármacos anula su eficacia ante futuras patologías bacterianas de gravedad. La OMS junto con la OPS¹ consideran que la resistencia a los antimicrobianos pone en peligro la eficacia de la prevención y el tratamiento de una serie cada vez mayor de infecciones por virus, bacterias, hongos y parásitos.

Desde la perspectiva del ejercicio farmacéutico, Armando, P., Moscardó, M. y Tellado, M.² describen que los farmacéuticos son los profesionales sanitarios más accesibles, que poseen un conocimiento científico del uso clínico de los medicamentos, debiendo participar activamente en el desarrollo de programas para combatirla mediante la

promoción, prevención y control de los tratamientos antimicrobianos, esta situación pone de manifiesto la presión asistencial y comercial a la que se ven sometidas las farmacias, donde el paciente llega exigiendo el producto sin contar con un récépé médico formal. La ausencia de este documento legal y clínico priva al individuo de una evaluación profesional que determine la posología y duración adecuada del tratamiento, factores determinantes para evitar la toxicidad farmacológica.

En este contexto, la relevancia del conocimiento del uso racional de antibióticos radica en el impacto clínico y social de las consecuencias a largo plazo, principalmente el desarrollo de resistencia bacteriana y la alteración de la microbiota normal del organismo. Es importante fortalecer el rol del farmacéutico como garante del uso racional del medicamento, protegiendo la salud y preservando el arsenal terapéutico para las futuras generaciones.

II. Antecedentes de la Investigación

En el ámbito internacional, destaca el trabajo de **Laxminarayan. E. (2024)**, titulado **"Serie The Lancet sobre resistencia a los antimicrobianos: la necesidad de un acceso sostenible a antibióticos eficaces"**. En esta serie documental y analítica, se expone que las infecciones bacterianas provocan anualmente 7,7 millones de muertes, de las cuales 4,95 millones están vinculadas directamente a bacterias resistentes. El estudio, fundamentado en modelos de datos novedosos, sostiene que en países de ingresos bajos y medianos, la mortalidad por esta causa podría reducirse en un 18% mediante la implementación de medidas preventivas y el fortalecimiento de la infraestructura sanitaria. La importancia de este antecedente para la

presente investigación radica en que establece una meta global crítica: la reducción del 20% en el uso inadecuado de antibióticos en humanos para el año 2030, subrayando que el uso irracional es un motor primario de la crisis de resistencia.

Asimismo, los autores proponen un enfoque multifacético que prioriza el acceso sostenible a medicamentos de la categoría "Acceso" de la OMS, mientras se restringe el uso inapropiado de las categorías de "Vigilancia" y "Reserva". Esta serie de The Lancet argumenta que garantizar la eficacia de los tratamientos requiere no solo innovación en nuevos fármacos, sino una voluntad política firme y marcos de rendición de cuentas que supervisen cómo se prescriben y dispensan estos agentes. Para este artículo, dicha referencia es fundamental, ya que valida la necesidad de estudiar el cumplimiento del recípe médico y el rol del farmacéutico como barreras de contención. Al alinear los hallazgos locales con los objetivos de la Asamblea General de las Naciones Unidas de 2024 mencionados por los autores, se refuerza la premisa de que el control estricto en la farmacia comercial es una herramienta indispensable para mitigar la carga mundial de la resistencia antimicrobiana (RAM).

Por otra parte, a nivel regional se presenta el estudio desarrollado por **Arriaga. A. (2025)**, titulado **"Uso Indiscriminado de Antibióticos en las Comunidades de Quetzaltenango, Guatemala"**, publicado en la Revista Médica CUNOC. Esta investigación consistió en un estudio descriptivo de corte transversal que aplicó 9,090 encuestas en 24 municipios, con el objetivo de analizar los factores que influyen en el uso irracional de estos fármacos. Los resultados revelaron una cifra alarmante: el 75,54% de los participantes reportó automedicación, siendo los factores socioeconómicos (falta de

recursos con un 38,55%) y la facilidad de adquisición (19,32%) los principales determinantes de esta conducta. El estudio destaca que la amoxicilina fue el antibiótico más frecuente (47,95%), utilizado erróneamente para síntomas como dolor de garganta y diarrea, lo que evidencia una problemática profundamente arraigada en el acceso deficiente a servicios médicos formales.

La importancia radica en la similitud de los patrones de consumo y las fallas de control observadas en el contexto latinoamericano. Los hallazgos refuerzan la premisa de que la facilidad de adquisición en establecimientos farmacéuticos es un factor crítico que propicia la automedicación masiva. Para esta investigación, dicho estudio es fundamental porque permite contrastar la realidad guatemalteca con la venezolana, demostrando que, independientemente de la región, el uso indiscriminado de betalactámicos responde a una percepción errónea del riesgo y a una falta de fiscalización en la venta sin receta. Estos datos validan la necesidad urgente de proponer estrategias de salud pública que no solo mejoren el acceso a la consulta médica, sino que garanticen que la farmacia deje de ser un punto de expendio libre para convertirse en un centro de uso racional de antimicrobianos.

Así mismo, a nivel suramericano, resulta pertinente citar el trabajo de **Olarte. P. (2022)**, titulado "**El uso de antibióticos y la amenaza de resistencia microbiana**", presentado ante la Universidad Nacional San Luis Gonzaga en Perú. Esta investigación, de carácter observacional y retrospectivo, analizó las tendencias de consumo y resistencia en un hospital público de Ica durante el periodo 2022-2024, determinando que el uso de antibióticos de la categoría "Access" representó solo el 36,29%, mientras que predominó el consumo de cefalosporinas y carbapenémicos (45,64%). El estudio reportó una alta prevalencia de

bacterias gramnegativas multirresistentes, como *K. pneumoniae* y *E. coli* productoras de betalactamasas de espectro extendido (BLEE), concluyendo que existe una correlación directa entre la prescripción excesiva de fármacos de amplio espectro y el fallo de las opciones terapéuticas convencionales.

Traslada la problemática del uso indiscriminado al entorno clínico y hospitalario, demostrando las consecuencias finales de la cadena de abuso de antimicrobianos. Para esta investigación, el estudio de Pari Olarte sirve como evidencia del impacto severo que tiene el incumplimiento de las normativas de prescripción, resaltando que la resistencia no es solo un fenómeno comunitario, sino una amenaza que prolonga las estancias hospitalarias y eleva la mortalidad. Al analizar la situación en Perú, país que comparte desafíos regulatorios similares a los de Venezuela en cuanto a la venta libre y la automedicación, se justifica la urgencia de aplicar programas de optimización y vigilancia desde las farmacias comerciales para evitar el colapso de los tratamientos de reserva en los centros de salud.

En complemento a las referencias anteriores, se incorpora el estudio de **Atnkut (2025)**, titulado **"Evaluación del uso inadecuado de antibióticos y sus factores contribuyentes en la zona administrativa de Awi, Etiopía"**, el cual consistió en una investigación transversal comparativa que analizó a 1.194 familias mediante un muestreo aleatorio estratificado. Los resultados arrojaron que el uso inseguro de antimicrobianos alcanzó un 57,5% en zonas urbanas y un 69,5% en áreas rurales, identificando mediante regresión logística que variables como el nivel educativo, los ingresos mensuales y el conocimiento previo del jefe de hogar son determinantes críticos en esta conducta. La investigación concluye con un llamado urgente a las

entidades autorizadas para reforzar la aplicación de normativas en las farmacias, garantizando que la dispensación esté estrictamente ligada a la provisión de información correcta sobre el uso de estos fármacos.

Para concluir, se incorpora el estudio nacional de **Comegna, M., Guzmán, M. y Colaboradores (2022)**, titulado **"Resistencia bacteriana a los antimicrobianos en Venezuela"**, el cual analiza la evolución del Programa Venezolano de Vigilancia de la Resistencia Bacteriana desde su creación. La investigación, basada en datos de una red de laboratorios de microbiología integrados al sistema internacional WHONET, documenta una tendencia alarmante en el aumento de cepas multirresistentes, destacando la producción de betalactamasas de espectro expandido por *E. coli* y *K. pneumoniae*, así como un incremento crítico en la resistencia a fluoroquinolonas. Los autores señalan que más del 40% de los pacientes hospitalizados en el país recibe uno o más antibióticos, clasificando a estos agentes como los medicamentos peor utilizados en el entorno clínico venezolano, donde el abuso terapéutico ha derivado en fracasos en los tratamientos y un aumento exponencial de los costos de hospitalización.

La importancia de este antecedente para el presente artículo es primordial, ya que proporciona el contexto epidemiológico local necesario para entender la magnitud del problema en Venezuela. A diferencia de los estudios internacionales, el trabajo valida que el país enfrenta desafíos específicos de resistencia bacteriana que han sido monitoreados por décadas, pero que se ven agravados por la falta de un uso racional de los medicamentos. Para esta investigación, dicha referencia es el pilar que justifica la necesidad de intervenir en las farmacias comerciales; si la resistencia ya es crítica a nivel hospitalario, el control de la dispensación en la comunidad es la primera línea de

defensa para evitar que la presión selectiva de bacterias resistentes continúe creciendo fuera de los centros de salud.

III. Objetivos de la Investigación

Objetivo General

Analizar, desde la experiencia de la práctica profesional farmacéutica, la automedicación con antibióticos y la percepción de los usuarios sobre su uso sin prescripción médica, con el fin de sensibilizar sobre el impacto que tiene esta conducta en la seguridad del paciente y en el agravamiento de la resistencia bacteriana.

Objetivos Específicos

- 1) Identificar, mediante la atención directa en el mostrador, el nivel de conocimiento que poseen los pacientes sobre los riesgos reales de la automedicación, especialmente en lo que respecta a la pérdida de eficacia de los fármacos y el daño a la flora intestinal.
- 2) Explorar la actitud y respuesta de los usuarios y del personal de farmacia ante la exigencia del recípe médico, observando cómo las dinámicas comerciales y sociales influyen en el cumplimiento de la normativa legal vigente.
- 3) Caracterizar los antibióticos con mayor demanda espontánea, relacionándolos con los malestares o síntomas que el paciente intenta resolver por cuenta propia, para entender las motivaciones detrás del uso indiscriminado de estos fármacos.

MATERIALES Y MÉTODOS

IV. Información que debe Contener el Recípe

En Venezuela, el expendio de antibióticos se rige por normativas estrictas que exigen la presentación de un recípe médico que debe cumplir con requisitos legales y sanitarios específicos. Según Allen, N.⁸ en su guía sobre récipes médicos en Venezuela, el cuerpo del documento debe contener de forma obligatoria los datos completos del paciente y la información detallada del médico, incluyendo nombre, apellido, cédula de identidad, dirección de consultorio, números de contacto y correo electrónico. Asimismo, es indispensable que el recípe especifique el nombre del medicamento, ya sea por su marca comercial o principio activo, junto con su concentración y posología clara. Para que el documento tenga validez legal ante la oficina de farmacia, debe presentar el sello húmedo de la institución de salud, el sello húmedo del médico donde conste su registro sanitario, y su firma, garantizando que la indicación y la duración del tratamiento han sido analizadas bajo criterios clínicos específicos para el caso.

V. Antibióticos Controlado

Dentro del marco regulatorio venezolano, es importante precisar que, si bien la Ley de Medicamentos y las normas del Instituto Nacional de Higiene "Rafael Rangel" establecen que la mayoría de los agentes antimicrobianos son de venta bajo prescripción médica, existen excepciones. Artículo 2 de la Gaceta Oficial Número 38.348⁹ Las farmacias, servicios farmacéuticos y cualquier otro establecimiento autorizado para dispensar medicamentos deberá solicitar el recípe a los medicamentos antimicrobianos contenidos en el artículo 3 de esta Resolución y registrarlos en los sistemas de, los cuales deberán estar disponibles para el momento que sean solicitados por la autoridad sanitaria.

Cuadro 1. Ejemplo de Antibióticos Controlados y No Controlados.

No Controlados	Controlados
Gentamicina, Tobramicina, Amoxicilina, Cefadroxilo, Tetraciclina, Amoxicilina con ácido clavulánico, Bactron y Amikacina.	Azitromicina, Ciprofloxacina, Levofloxacina, Cefixima, Ampicilina sulbactam, Sultamicilina, Ceftazidina, Eritromicina y Vancomicina.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Muchos clientes intentaron adquirir antibióticos en la farmacia comercial sin poseer un recípe médico, fundamentando su solicitud en experiencias previas o recomendaciones de terceros. Entre los fármacos más demandados destaca la azitromicina, solicitada principalmente para tratar síntomas de origen viral. Asimismo, se observó que, si bien la mayoría de los pacientes reconoce el nombre comercial del medicamento, pocos poseen conocimientos técnicos sobre el mecanismo de acción de los antimicrobianos o las consecuencias de la resistencia bacteriana.

En cuanto a la gestión farmacéutica, los datos indican que la exigencia del recípe con todos los requisitos legales (datos completos del médico, sellos húmedos y posología detallada) es inconsistente, permitiéndose la dispensación en situaciones donde el documento carece de información de contacto o firma vigente, lo que facilita la adquisición irregular del tratamiento.

Estos hallazgos demuestran una preocupante brecha entre la normativa legal vigente en Venezuela y la praxis cotidiana en las farmacias comerciales, donde la percepción del antibiótico como un bien de consumo inmediato prevalece sobre su naturaleza de fármaco controlado. La elevada incidencia de automedicación para procesos virales evidencia una falla en la educación sanitaria del paciente, quien al ignorar la toxicidad y el impacto en la microbiota intestinal, incurre en prácticas que aceleran la presión selectiva bacteriana. Esta situación coincide con la literatura internacional, la cual advierte que la dispensación sin recípe es un factor determinante en el fracaso de las políticas de uso racional de medicamentos. Por consiguiente, los resultados sugieren que la resistencia antimicrobiana no es solo un fenómeno biológico, sino un problema sociocultural alimentado por la falta de fiscalización rigurosa y la necesidad de fortalecer el rol asistencial del farmacéutico como último filtro de seguridad para el paciente.

CONCLUSIONES

El farmacéutico desempeña un rol crítico y multifacético como garante de la seguridad farmacológica, actuando como la última barrera de contención frente al uso irracional de antimicrobianos. No obstante, el ejercicio de esta responsabilidad se ve severamente obstaculizado por el desconocimiento generalizado de la población sobre la normativa sanitaria. Esta falta de educación sanitaria genera que, al negar la dispensación de un antibiótico sin el debido recípe, el personal de farmacia deba enfrentar situaciones de conflicto con clientes que muestran actitudes alteradas, hostiles o de frustración. El usuario, al percibir el medicamento como un producto de libre adquisición y no como una sustancia de riesgo biológico, interpreta la exigencia legal del

récipe como un obstáculo burocrático y no como una medida de protección para su salud y para la microbiota intestinal.

Asimismo, la eficacia de las políticas de control en Venezuela es limitada debido a la falta de uniformidad en los criterios de dispensación entre los distintos establecimientos farmacéuticos. El hecho de que algunas farmacias omitan la validación rigurosa de los sellos húmedos o la firma del médico para asegurar una venta inmediata debilita la autoridad del profesional farmacéutico que sí cumple con la ley, incentivando al paciente a buscar el fármaco en locales con menor fiscalización. Esta inconsistencia institucional no solo perpetúa la práctica de la automedicación, sino que invalida los esfuerzos colectivos para frenar la resistencia antimicrobiana. Por lo tanto, es imperativo estandarizar los procesos de vigilancia y fortalecer la capacitación en técnicas de comunicación asertiva para el personal de farmacia, permitiéndoles manejar usuarios conflictivos mientras mantienen su compromiso ético y legal con la salud pública.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- 1 Organización Panamericana de la Salud (2025). Resistencia a los antimicrobianos. Disponible en: <https://www.paho.org/es/temas/resistencia-antimicrobianos>
- 2 Armando, P., Moscardó, M., & Tenllado, M. (2025). Buenas prácticas de dispensación de antibióticos en farmacias comunitarias de la provincia de Córdoba, Argentina. Farmacéuticos Comunitarios. Disponible en: <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC12020982/>
- 3 Laxminarayan. E. (2024). Serie The Lancet sobre resistencia a los antimicrobianos: la necesidad de un acceso sostenible a antibióticos eficaces. One Health Trust. Disponible en: https://onehealthtrust.org/publications/peer-reviewed-articles/the-lancet-series-on-antimicrobial-resistance-the-need-for-sustainable-access-to-effective-antibiotics/?gad_source=1&gad_campaignid=21377001781&gbraid=0AAAAABuwn0VUI9OVeTIWvvm19pM3zfsTs&gclid=

[CjwKCAiAjojLBhAlEiwAcjhrDi3o2MeZ5jRpWBOcM-uwJx-PKfxoabkoLj8lvLPxTxW1Sv8j3bKvsRoCpmUQAvD_BwE](https://cienciacunoc.org/index.php/revmed/article/view/10/6)

- 4 Arriaga. A. (2025). Uso Indiscriminado de Antibióticos en las Comunidades de Quetzaltenango, Guatemala. Disponible en: <https://cienciacunoc.org/index.php/revmed/article/view/10/6>
- 5 Olarte. P. (2022). El uso de antibióticos y la amenaza de resistencia microbiana. Disponible en: <https://www.siicsalud.com/des/expertoimpreso.php/175657>
- 6 Atnkut (2025). Evaluación del uso inadecuado de antibióticos y sus factores contribuyentes en la zona administrativa de Awí, Etiopía. Disponible en: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S205229752400341X>
- 7 Comegna, M., Guzmán, M. y Colaboradores (2022). Resistencia bacteriana a los antimicrobianos en Venezuela. Disponible en: https://ve.scielo.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1315-25562000000100012
- 8 Allen, N. (2025). Recípes médicos en Venezuela, tipos, normas y diseño. Digital Graphics. Disponible en: <https://digitalgraphicsfd.com/blog/recipes-medicos-en-venezuela/>
- 9 Gaceta Oficial Número 38.348 (206). Artículo 2. Disponice en: <https://cavefar.org.ve/wp-content/uploads/2025/07/GO-38348-02-01-2006-antibioticos-controlados.pdf>